

• 用药指南 •

甾体避孕药的药物相互作用

新疆奎屯州医院药局(833200) 朱虹 王森

摘要 报道甾体避孕药减弱避孕效果的配伍、影响其它药物疗效的配伍、加重不良反应的配伍等。

关键词 甾体避孕药 相互作用

甾体避孕药是迄今所有节制生育中最可靠的方法。由于目前临床上甾体避孕药几乎全都是女用避孕药,且伍用现象十分频繁,时常导致避孕失败或严重不良反应的发生,从而给女性造成许多痛苦。为引起医生注意,笔者将其配伍作一综述。

1 减弱避孕效果的配伍

1.1 与抗癫痫药 苯巴比妥、扑痫酮、甲琥胺、卡马西平等抗癫痫药为肝药酶诱导剂,可促进并加速口服甾体避孕药的代谢速度,同时服用,增加突破性出血率和避孕失败率,还可引起癫痫患者体液潴留,癫痫恶化和诱发癫痫发作。正在服用抗癫痫药的患者,不宜同时口服甾体避孕药,以采用其它避孕措施为好,或改用丙戊酸钠治疗。

1.2 与催眠药、肝药酶诱导剂 格鲁米特(导眠能)、甲丙氨酯(安宁)等非巴比妥类催眠药;双氢麦角胺、异丙嗪、非那西汀、安替比林、氨基比林、保泰松、氯氮草(利眠宁)、安定、灰黄霉素、新霉素,及吩噻嗪类药物氯丙嗪、奋乃静、氟奋乃静、三氟拉嗪等均属肝药酶诱导剂,合用可加速雌激素代谢率而导致避孕失败。利福平为强药酶诱导剂,可明显提高雌、孕激素代谢率,加速其灭活,而导致避孕药减效、甚至失败,并可引起月经周期紊乱,故利福平与低剂量甾体避孕药同服时,应加用其它非甾体激素类避孕方法。

1.3 与抗菌药物 甾体避孕药为肠肝循环类药物,当肠道菌群受抗菌药物抑制后,甾体避孕药的吸

佐卡因 10.0g,滑石粉加至 100.0g。软膏类外用有肤轻松、地塞米松、皮炎平、肤疾宁。使用皮质激素类药物时间长、面积大,大量吸收后轻者局部皮肤萎缩、毛细血管扩张、重则引起全身性副作用,应引起重视。

3.2 中药外用制剂 传统中药软膏、粉剂对湿疹效果好、见效快,在临床用药中尚未发现明显的副作用。一般用淡盐水清洗患处,擦干后上药,1次/d。外贴消毒纱布。在有较多渗液的情况下,则上皮粘

收和利用则受到障碍而导致血浓度下降,故二者并用影响避孕效果甚至避孕失败。

2 影响其它药物疗效的配伍

2.1 增强药物疗效 ①甾体避孕药为药酶抑制剂,能抑制甲喹酮、苯二氮草类抗焦虑药氟氮草、安定、硝基安定、三唑仑(三唑安定);三环类抗抑郁药米帕明(丙咪嗪)、茶碱;苯妥英钠等药物在肝内的代谢,从而增加其血浓度,延长其半衰期,合用时需注意调整这些药物的剂量。安定与甾体避孕药同时服用,可使精神运动及识别能力明显抑制,产生行为障碍,应减少安定剂量。②与哌替啶:甾体避孕药可抑制其代谢,使其镇痛作用及中枢抑制作用增强,故口服避孕药的妇女宜慎用哌替啶。③与环孢霉素 A:甾体避孕药通过抑制肝药酶活性而抑制环孢霉素 A 的代谢,使其血浓度增高,作用和毒性均增强,合用应监测其血浓度,相应调整剂量。④与维生素 A:甾体避孕药与维生素 A 同时服用,维生素 A 的血浓度显著增加。⑤与氨基比林、保泰松:氨基比林、保泰松等是经肝脏去甲基代谢而失效的,甾体避孕药能影响去甲基过程,故可延长其半衰期,使其作用增强,作用时间延长。⑥与美沙酮:两药同时服用可显著增强美沙酮的中枢抑制作用,易导致终日疲倦乏力,头昏甚至昏迷,且易引起心律失常。⑦与咖啡因:甾体避孕药能抑制其在肝内代谢,使其血浓度升高和蓄积,并需长时间方可消除,故并用时咖啡因宜减量。⑧与饮酒:甾体避孕药可降低乙醇在体内代谢,使其

散。也可采用红外线照射,干燥后再上药膏。外贴消毒纱布避免擦掉药物,有利于药物的渗透吸收。常用的有蛇黄膏、皮粘散。蛇黄膏配方:蛇床子、赤石脂各 1500g,广丹、寒水石各 750g,黄柏 3000g。将药研成细末,加凡士林调匀制成 20%油膏,外敷患处。皮粘散配方:朱砂 6g,琥珀 24g,硼砂 4.5g,熊胆 12g,冰片 0.6g,珍珠 1~2g,麝香 0.6g,炉甘石 60g,先用黄连 30g(煎水淬 4 次,研细)。

将上药共研为极细末,喷撒患处。

(1996-02-06 收稿)

氧氟沙星葡萄糖注射液与常用六种药物配伍实验

湖南省益阳市中心医院(413000) 肖科武 龙艾兵 卓庆如 郭利民 李宪为 陈小英

摘要 模拟临床常用药物浓度分别将地塞米松、氨基己酸、庆大霉素、维生素 C、氨苄青霉素、甘露醇注射液与氧氟沙星葡萄糖注射液进行了配伍实验。结果:氧氟沙星葡萄糖注射液除与氨苄配伍 pH 值升至 8.10,外观淡黄绿色变淡,余各药均无外观及 pH 值变化,紫外分光光度法测定含量 3h 后在 90.0%~110.0%范围。结果显示,氧氟沙星葡萄糖注射液与上述 6 种药物配伍 3h 内稳定,无理化配伍禁忌。

关键词 氧氟沙星 药物配伍

氧氟沙星属于第 3 代喹诺酮类合成抗菌药,具有广谱、高效、低毒等特点。通过对细菌 DNA 回旋酶的抑制作用使细菌失活^[1]。由于临床的广泛使用,其耐药性报道^[2]也有所出现,氧氟沙星葡萄糖注射

作用增强;也有人认为可提高对乙醇的耐受性。

2.2 降低药物疗效 ①与叶酸及维生素 B₁₂:口服甾体避孕药后叶酸代谢受阻,降低维生素 B₁₂与血浆蛋白结合,增加组织对维生素 B₁₂的亲合性,改变维生素 B₁₂的再分布,从而使血清中维生素 B₁₂的水平降低。因此孕妇易患叶酸盐缺乏症,特别是停服避孕药后怀孕的妇女应补充叶酸盐。②与抗凝剂:口服甾体避孕药能增加某些凝血因子的合成而降低抗凝作用,这对口服避孕药导致深静脉血栓妇女应用抗凝剂有其重要性,因在停用避孕药后,要应用大剂量的抗凝剂数天。二药不可同用。③去甲羟安定(奥塞西洋)氯羟安定、羟基安定等苯二氮草类抗焦虑药及醋氨酚(扑热息痛)在肝内主要以葡萄糖醛酸结合形式进行代谢,现已知甾体避孕药能促进此反应,故合用可降低血浓度,从而减弱药效。炔雌醇可减弱米帕明的抗抑郁效果,故并用易发生昏睡、低血压等不良反应。④与降压药:甾体避孕药可降低甲基多巴、胍乙啶、环戊噻嗪的疗效。这可能是甾体避孕药易导致水钠潴留的结果,故服用上述药物应停服甾体避孕药。⑤与氯贝丁酯(安妥明):合用可降低其疗效,胆固醇浓度相应升高。

3 加重不良反应的配伍

3.1 与肝药酶抑制剂 西咪替丁、去氢甲睾酮、别嘌呤、对氨基水杨酸、甲硝唑、流感疫苗、卡介苗、双硫仑(戒酒硫)、哌醋甲酯、华法令、氯霉素、三环类抗抑郁药米帕明、单胺氧化酶抑制剂苯乙肼、苯环丙胺、帕吉林(优降宁)、异烟肼、呋喃唑酮等均为肝药酶抑制剂,理论上均可增强避孕药的作用,延缓代谢,增加不良反应,还可增加体液潴留、高血压、血栓栓塞、和致糖尿病等副作用。故服用避孕药的妇女应

液能否与其它药物配伍静滴,未见报道。本文模拟临床常用药物浓度分别将地塞米松、氨基己酸、庆大霉素、维生素 C、氨苄青霉素、甘露醇注射液与氧氟沙星葡萄糖注射液进行配伍实验,现报道如下。

慎用这些药物,对可能出现的副反应要定期询问、监护。此外与米帕明、甲基多巴、利血平等合用可激发催乳激素分泌,易导致乳房肥大及乳溢。

3.2 与氨基己酸 甾体避孕药能提高血中凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅹ、Ⅹ的浓度,产生高凝状态,故不宜合用。

3.3 与糖皮质激素 甾体避孕药能显著抑制其代谢,可能是增加了后者与血浆蛋白结合所致,并用可增强糖皮质激素作用和副作用,宜适当减少糖皮质激素类药物剂量;而糖皮质激素类药物(如氢化可的松)也可延缓雌、孕激素在肝内的代谢,增强避孕药的作用和副作用。

3.4 与降血糖药 甾体避孕药可降低妇女对葡萄糖的耐受量,使糖尿病症状加剧,胰岛素需要量增加;糖尿病患者服用避孕药后其心血管并发症、微血管变化危险性均增加,故糖尿病患者宜改用其它避孕方法或改变原来的糖尿病治疗方法。

3.5 维生素 C 维生素 C 可增加甾体避孕药生物利用度,尤其是提高炔雌醇的血浓度,而甾体避孕药可导致血浆、白细胞和血小板中维生素 C 的浓度降低,从而改变血小板电位,使之易于发生聚集,而引起血栓栓塞性疾病。故口服避孕药期间,应适当补充维生素 C。

3.6 与三乙酰竹桃霉素 同时服用可致皮肤瘙痒、肝酶升高及黄疸。

3.7 与吸烟 吸烟可增加甾体避孕药对心血管的损害,使心肌梗塞、动静脉血栓和蛛网膜下腔出血发生率增加,>35 岁的妇女吸烟>15 支/d 时,这种危险性更大。

(1996-03-06 收稿)